

03 - 03- Troubles Psychiques de la Grossesse et du Post Partum - Pr. ADALI

(0:00 - 0:22)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce cours sur les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum. La grossesse est un événement majeur dans la vie d'une femme. C'est une période marquée par des changements importants sur le plan psychique, hormonal, somatique, familial et social.

(0:23 - 1:08)

L'adaptation au nouveau rôle de maman et de ses importantes responsabilités peut entraîner un déséquilibre psychologique, notamment en cas de vulnérabilité psychique. Les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum s'étendent de la conception à la première année du postpartum et constituent un enjeu majeur de santé publique, de par leurs conséquences négatives sur la santé de la maman, le développement de l'enfant et sur la qualité de vie du couple. Du point de vue épidémiologique, les femmes ont plus de risque de présenter une maladie mentale sévère dans les trois mois qui suivent l'accouchement.

(1:09 - 1:46)

Elles ont deux fois plus de risque d'être hospitalisées en milieu psychiatrique dans l'année qui suit la naissance. La dépression du postpartum est la complication postnatale la plus fréquente dans les pays développés. En outre, la dépression du postpartum a une fréquence élevée estimée à 13%, surtout dans les premières semaines du postpartum où le risque est multiplié par 3. Le risque de récurrence est élevé, estimé entre 30 et 50% lors d'une grossesse ultérieure.

(1:48 - 2:20)

La fréquence du blues du postpartum est estimée entre 26 et 85% dès accoucher. Quant à la psychose postpartale, sa prévalence est de 1 à 2 cas pour 1000 accouchements. Les troubles psychiques de la grossesse comprennent les réactions physiologiques mineures, les manifestations psychosomatiques, les manifestations anxieuses, les états dépressifs et les troubles psychotiques.

(2:23 - 2:51)

Les réactions psychologiques mineures sont souvent transitoires, comprennent une irritabilité, l'habileté émotionnelle, des modifications des conduites alimentaires avec grignotage et envie et des troubles du sommeil. Les nausées et vomissements gravidiques sont considérés comme étant des troubles psychiques de la grossesse. Ils se voient dans 50% des cas sans retentissement sur l'état général.

(2:51 - 3:15)

Ces troubles disparaissent spontanément au deuxième trimestre. Dans certains cas, ils peuvent s'aggraver et persister avec un retentissement à type de déshydratation et troubles hydroélectrolytiques. Les manifestations anxieuses comprennent les inquiétudes et préoccupations se rapportant directement à la grossesse.

(3:17 - 3:50)

Elles sont plus fréquentes au premier et au dernier trimestre de la grossesse. Les thèmes sont les modifications corporelles de la maman, l'état du fœtus avec crainte de malformation ou de mort fœtale in utero, le déroulement de l'accouchement, les conduites de maternage auprès du bébé. Les manifestations anxieuses peuvent être graves car elles peuvent favoriser le déclenchement des contractions utérines et augmenter le risque d'accouchement prématuré.

(3:55 - 4:16)

Les épisodes dépressifs au cours de la grossesse touchent environ 10 à 20 % des femmes enceintes. Ils sont souvent d'intensité légère ou moyenne. On y trouve un sentiment de culpabilité centré sur le fœtus et un sentiment d'incapacité concernant la maternité.

(4:16 - 4:35)

Les dépressions sévères voire mélancoliques sont rares pendant la grossesse. Les troubles psychotiques sont très rares pendant la grossesse et imposent une surveillance stricte à la fois obstétrique et psychiatrique. Ils posent aussi un problème de traitement au cours de la grossesse.

(4:35 - 5:26)

Le deuxième grand chapitre est celui des troubles psychiques du postpartum, qui comprennent le blues du postpartum, les troubles de l'humeur du postpartum, la psychose du postpartum, qu'on appelle psychose purpérale, la dépression après interruption volontaire ou médicale de la grossesse ou mort fatale in utero. Le blues du postpartum, appelé aussi baby blues ou syndrome du troisième jour, est un trouble léger et transitoire, considéré comme une réaction normale à l'expérience de la naissance. Il est spontanément résolutif en 4 à 7 jours.

(5:27 - 6:09)

Il comprend l'habileté de l'humeur allant des pleurs à l'euphorie brève, une irritabilité, une anxiété, un sentiment d'incapacité à s'occuper de son enfant, un sentiment d'être délaissé, une asthémie et des plaintes somatiques. L'intensité des signes et leur persistance au-delà de 7 jours témoignent de son évolution vers un trouble dépressif. La dépression du postpartum, appelée trouble dépressif non spécifié avec début lors du péripartum dans le DSM-5, est généralement

d'intensité légère à modérée.

(6:10 - 6:45)

L'humeur est triste, on note une irritabilité, une asthémie importante, des phobies d'impulsion, c'est-à-dire une peur de faire du mal à son enfant, un sentiment d'incapacité et auto-accusation concernant la fonction maternelle. La dépression du postpartum peut se manifester à travers les troubles du sommeil et de l'alimentation chez le bébé. Ainsi que les coliques, les pleurs fréquentes chez le nourissant ou par des troubles, des interactions mère-bébé.

(6:49 - 7:18)

La mélancolie du postpartum se voit dans 1% des cas. Le syndrome dépressif est d'intensité sévère avec souffrance morale importante. On note une thématique délirante centrée sur le nourissant, idée de substitution, d'empoisonnement, d'envoûtement ou une thématique centrée sur la filiation, une négation de la maternité, un enfant considéré comme étant un enfant de Dieu, etc.

(7:20 - 7:43)

Les angoisses de mort sont massives et concernent l'enfant, la mère elle-même. Le risque de suicide et ou d'infanticide est majeur. La psychose du postpartum est un trouble psychiatrique sévère et très rare.

(7:44 - 7:58)

C'est une urgence psychiatrique, diagnostique et thérapeutique. Il faut penser à la thrombophlébite cérébrale d'abord. Le début est brutal, de 48h à 72h après la naissance.

(7:59 - 8:20)

Les premiers symptômes sont les troubles de sommeil ou l'irritabilité, un désintérêt progressif à l'égard de l'enfant, une confusion. Dans la phase d'état, le tableau est polymorphe. Il inclut des manifestations timides par une alternance de phases mélancoliques et des phases maniaques.

(8:23 - 9:18)

Dans la psychose du postpartum, le syndrome délirant est de mécanismes polymorphes, de thématiques centrées sur la maternité, l'accouchement, sur le nouveau-né qui est souvent perçu comme un persécuteur. On note une déshallucination, une note confusionnelle, un comportement désorganisé, incompréhensible, une dépersonnalisation. Suicides et infanticides sont toujours à redouter.

Ils peuvent être brutaux et imprévisibles. L'interruption volontaire ou médicale de la grossesse, ou l'abord fœtal et utéro sont des événements qui peuvent prendre un caractère traumatique et

causer une dépression. Le sentiment de culpabilité maternelle est très important.

(9:19 - 9:56)

Le deuil d'un enfant mort avant la naissance est difficile à accomplir. Il constitue un facteur favorisant la survenue d'une dépression lors d'une autre grossesse et retentit sur la façon dont est investie l'enfant à venir. Les facteurs de vulnérabilité psychique sont les antécédents de carences affectives, de maltraitements, d'abus sexuels pendant l'enfance, les antécédents personnels ou familiaux de troubles psychiatriques, la consommation de substances psychoactives.

(9:59 - 11:21)

La rapidité des bouleversements endocriniens lors de la grossesse et de l'accouchement constituent l'essentiel des facteurs biologiques causant les troubles psychiatriques de la grossesse et du postpartum. Les facteurs de risques gynécologiques et médicaux sont la primiparité, l'interruption de la grossesse, qu'elle soit volontaire ou médicale, la suspicion de malformations anténatales, l'accouchement prématuré, l'accouchement dystoïque, la césarienne, surtout en urgence et ou sous anesthésie générale, et les maladies chroniques de la maman. Les facteurs psychosociaux et l'histoire personnelle de la maman jouent un rôle important dans l'apparition des troubles psychiques de la grossesse et du postpartum, notamment les grossesses non désirées, la jeûne, notamment l'adolescence, l'ère célibataire, les conflits conjugaux, les antécédents de décès d'un enfant, le deuil périnatal d'une personne proche, les événements de vie stressants pendant la grossesse, l'isolement familial et social, et la précarité socio-économique.

(11:26 - 11:59)

La dépression pendant la grossesse est un facteur de risque de complications obstétricales, avec menaces d'accouchement prématuré, un bas poids à la naissance et autres. Chez l'enfant, on note des troubles comportementaux, agitation psychomotrice ou apathie, relationnel ou à expression somatique, des coliques et des troubles du sommeil. Plus tard, on note un retard d'apprentissage, des troubles du comportement, des troubles émotionnels et autres.

(12:03 - 12:21)

La dépression du postpartum affecte la qualité de vie et le fonctionnement du couple. Elle a des conséquences négatives sur l'interaction de la maman avec son enfant et sur son développement cognitif et affectif. Elle peut être cause de maltraitance de l'enfant de la part de sa maman.

(12:24 - 13:07)

Dans la psychose purpurale et ou dans la mélancolie, il faut craindre l'infanticide et le

néonaticide. Les principes généraux de la prise en charge sont d'abord la prévention et le dépistage des troubles. Lors des consultations de suivi de grossesse et celles des premières semaines du postpartum par les pédiatres, les gynécologues, les médecins généralistes et tout intervenant de santé, les facteurs de risque psychique maternel devraient être recherchés en routine dans les prises en charge de santé périnatales.

(13:11 - 13:57)

La prescription de psychotropes expose le risque d'effets tératogènes, surtout de certains médicaments courts du premier trimestre, des symptômes d'imprégnation et de sevrage, surtout en néonatale, et peut causer des symptômes psychomoteurs comportementaux et ou cognitifs au long terme en postnatale. Dans la prise en charge, il faut évaluer le rapport bénéfice-risque de la prescription des psychotropes. Choisir la molécule qui a le plus de recul.

(13:58 - 14:12)

Commencer par la posologie efficace la plus faible. Diminuer les posologies en fin de grossesse. Surveiller le développement fœtal et il est conseillé d'arrêter l'allaitement.

(14:12 - 15:00)

La prise en charge des manifestations anxieuses pendant la grossesse se base sur les psychothérapies de soutien avec l'écoute des dramatisations et informations de la maman sur son rôle auprès de son enfant. Les techniques corporelles visent principalement la relaxation et la préparation à l'accouchement. Un traitement anxiolytique tel que l'hydroxyzine, la Tarax ou l'oxazepam, Seresta, peuvent être proposés pendant la grossesse si nécessité.

(15:03 - 15:34)

Pendant la grossesse, le traitement des épisodes dépressifs repose sur les psychothérapies, Certains antidépresseurs, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, notamment la fluoxétine, la sertraline, les citalopram, peuvent être prescrits. La paroxétine est à ne pas prescrire pendant le premier trimestre. Les timorégulateurs peuvent être prescrits chez la femme enceinte, notamment la lamotrigine et le lonzapine.

(15:35 - 15:56)

Le lithium et valproate sont contre-indiqués. Pour les troubles psychotiques pendant la grossesse, une hospitalisation en milieu psychiatrique peut être indiquée. Les traitements par l'aldol, la chlorpromazine, le lonzapine sont les plus occupantés.

(16:01 - 16:35)

En postpartum, pour les traitements du baby blues, il faut favoriser la présence de l'entourage,

particulièrement le père, avec des attitudes de soutien, des capacités maternelles, en évitant de la culpabiliser. En cas de dépression du postpartum d'intensité sévère, une hospitalisation est indiquée. Dans la dépression du postpartum, un anxiolytique et un antidépresseur de type IRS sont indiqués.

(16:36 - 16:49)

On propose l'électroconvulsivothérapie si cas sévère. La psychose du postpartum est une urgence thérapeutique. Imposons une hospitalisation en urgence en milieu psychiatrique.

(16:50 - 17:06)

On prescrit un antipsychotique et un anxiolytique. Et le CT si cas sévère. En conclusion, l'accès aux soins en santé mentale en période périnatale doit être amélioré.

(17:06 - 17:27)

La prévention, la promotion de la santé maternelle périnatale est un travail qui devrait se faire au réseau, c'est-à-dire incluant psychiatres, pédopsychiatres, gynécologues, pédiatres, dont le coordinateur pourrait être le médecin généraliste ou le médecin de famille. Et je vous remercie pour votre attention.